

Gota y Pseudogota

1. Introducción y relevancia clínica

La **gota** es una **enfermedad metabólica inflamatoria** producida por el **depósito de cristales de urato monosódico** en las articulaciones y tejidos periarticulares, secundario a **hiperuricemia persistente**.

Se caracteriza clínicamente por **episodios agudos de artritis muy dolorosa**, que en su forma típica compromete la **primera articulación metatarsofalángica (podagra)**.

Es una de las artritis más comunes en adultos, especialmente **hombres mayores de 40 años**, y su incidencia está en aumento debido a factores dietéticos, envejecimiento, uso de diuréticos y comorbilidades como obesidad y síndrome metabólico.

Por su frecuencia y relevancia terapéutica, la gota es un **tema clásico del EUNACOM**, donde suelen evaluarse:

- Clínica característica (monoartritis aguda de base del hallux).
- Confirmación diagnóstica por cristales birrefringentes negativos.
- Tratamiento del ataque agudo y manejo de la hiperuricemia.

La **pseudogota** o **condrocalcinosis** es una entidad similar, pero causada por **depósito de cristales de pirofosfato de calcio**, afectando habitualmente rodillas y muñecas en adultos mayores.

Ambas comparten manifestaciones clínicas, pero difieren en su etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Gota

La gota se produce por **hiperuricemia**, definida como niveles séricos de **ácido úrico >6,8 mg/dL**, punto en el cual el urato puede cristalizar.

El ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas. Cuando su concentración se eleva, los **cristales de urato monosódico** se depositan en las articulaciones, tendones y tejidos blandos, activando macrófagos y el **inflammasoma NLRP3**, que libera **IL-1 β** , responsable de la intensa respuesta inflamatoria.

Los episodios de artritis aguda ocurren cuando los cristales se liberan al líquido sinovial, activando neutrófilos y desencadenando inflamación autolimitada.

2.2. Causas de hiperuricemia

A. Aumento de producción de ácido úrico:

- Dieta rica en purinas (carnes rojas, vísceras, mariscos).
- Alcohol (especialmente cerveza y licores destilados).
- Síndromes mieloproliferativos, lisis tumoral.
- Enzimas defectuosas (déficit de HGPRT, síndrome de Lesch-Nyhan).

B. Disminución de excreción renal:

- Insuficiencia renal crónica.
 - Uso de diuréticos tiazídicos o de asa.
 - Ciclosporina, etambutol, pirazinamida.
 - Hipotiroidismo y obesidad.
-

2.3. Fases clínicas de la gota

1. **Hiperuricemia asintomática:** puede durar años; no todos los pacientes desarrollan artritis.
 2. **Artritis gotosa aguda:** inflamación articular intensa, monoarticular, de inicio brusco.
 3. **Periodo intercrítico:** intervalo libre de síntomas entre ataques.
 4. **Gota tofácea crónica:** depósitos subcutáneos de cristales ("tofos") y daño articular destructivo.
-

2.4. Pseudogota (Condrocalcinosis)

Causada por depósito de **cristales de pirofosfato de calcio dihidratado (CPPD)** en cartílago y líquido sinovial.

Su fisiopatología incluye alteración en el metabolismo del pirofosfato y envejecimiento del cartílago.

Se asocia a **enfermedades metabólicas** como hipomagnesemia, hiperparatiroidismo, hemocromatosis e hipofosfatasa.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Gota aguda

- Inicio brusco, usualmente nocturno.
- Dolor intenso, eritema, calor y tumefacción articular.
- Frecuentemente afecta la **primera metatarsofalángica (podagra)**, pero también tobillo, rodilla o articulaciones pequeñas.
- Fiebre y compromiso general pueden simular infección.
- El episodio alcanza su máxima intensidad en 12–24 horas y se resuelve en 5–10 días.

Signo característico: piel sobre la articulación brillante, tensa y eritematosa.

Comentario EUNACOM:

El hallazgo clásico de una **monoartritis aguda en el hallux** en un hombre de mediana edad o hipertenso tratado con diuréticos debe orientar inmediatamente a **gota aguda**.

3.2. Gota tofácea crónica

- Múltiples tofos (nódulos firmes e indoloros) en pabellones auriculares, olecranon, tendón de Aquiles y articulaciones pequeñas.
 - Poliartritis crónica con erosiones óseas y deformidades.
-

3.3. Pseudogota

- Crisis artrítica aguda, habitualmente en **rodilla o muñeca**.
 - Más común en **ancianos y mujeres**.
 - Menor intensidad que la gota, pero de evolución más prolongada.
 - Puede coexistir con artrosis o enfermedades metabólicas.
-

3.4. Diagnóstico diferencial

- **Artritis séptica:** fiebre alta, leucocitosis marcada, líquido sinovial con cultivo positivo.
 - **Artritis reumatoide:** poliartritis crónica simétrica, FR positivo.
 - **Artrosis:** dolor mecánico sin inflamación evidente.
 - **Pseudogota:** cristales distintos en el líquido sinovial.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Laboratorio

- **Ácido úrico sérico:** elevado (>7 mg/dL), aunque puede ser normal durante un ataque agudo.
- **VSG y PCR:** elevadas en fase aguda.
- **Función renal y electrolitos:** evaluar excreción renal y comorbilidades.

4.2. Artrocentesis (confirmación diagnóstica)

- **Líquido sinovial inflamatorio**, con abundantes leucocitos ($2.000\text{--}50.000/\text{mm}^3$).
- **Cristales de urato monosódico:** forma de aguja, birrefringencia negativa bajo luz polarizada.

- En pseudogota: **cristales romboidales de pirofosfato de calcio**, birrefringencia positiva.

4.3. Imágenes

- **Radiografía:** erosiones con borde sobre elevado (“signo del mordisco”) en gota crónica.
 - **Ecografía articular:** signo del “doble contorno” (depósito de urato en cartílago).
 - **TC dual-energy:** puede visualizar depósitos de urato en tejidos blandos.
-

5. Tratamiento (según MINSAL 2023 y EULAR 2023)

El manejo de la gota tiene tres objetivos:

1. Tratar el ataque agudo.
 2. Prevenir recurrencias.
 3. Mantener uricemia <6 mg/dL (<5 mg/dL si tofácea).
-

5.1. Tratamiento del ataque agudo

Debe iniciarse **lo antes posible (primeras 24 h)**.

Opciones terapéuticas:

- **AINES:** naproxeno, indometacina o diclofenaco por 5–10 días.
- **Colchicina:** 1 mg inicial + 0,5 mg cada 2–3 h hasta máximo 3 mg/día o resolución de síntomas.
- **Corticoides:** prednisona 20–30 mg/día por 3–5 días si AINEs o colchicina están contraindicados.
- **Infiltración articular:** alternativa en monoartritis con buena respuesta.

Medidas complementarias:

- Reposo de la articulación.
- Hielo local.
- Hidratación adecuada.
- Suspender fármacos hiperuricemiantes (diuréticos, aspirina).

Comentario EUNACOM:

Durante un ataque agudo **no se deben iniciar ni suspender fármacos hipouricemiantes**, ya que pueden prolongar la crisis.

5.2. Tratamiento intercrítico (profilaxis y prevención de recurrencias)

Iniciar **terapia hipouricemiante** en:

- ≥ 2 ataques al año.
- Nefrolitiasis urática.
- Gota tofácea crónica.
- Daño articular radiológico.

A. Fármacos hipouricemiantes

1. Alopurinol (xantina oxidasa inhibidor):

- Dosis inicial: 100 mg/día, ajustar hasta uricemia < 6 mg/dL.
- Máximo: 300–600 mg/día.
- Reducir dosis en insuficiencia renal.
- Riesgo raro de hipersensibilidad grave (rash, hepatotoxicidad).

2. Febuxostat: alternativa en intolerancia a alopurinol.

3. Uricosúricos (probenecid, benzbromarona):

- Aumentan excreción renal de urato.
- Contraindicados en nefrolitiasis o insuficiencia renal.

B. Profilaxis durante inicio del tratamiento

- Asociar **colchicina 0,5 mg/día** o **AINE** durante los primeros 3–6 meses para prevenir crisis por movilización de cristales.
-

5.3. Tratamiento no farmacológico

- Evitar alimentos ricos en purinas: carnes rojas, vísceras, mariscos.
 - Reducir consumo de alcohol, especialmente cerveza.
 - Mantener peso adecuado y controlar síndrome metabólico.
 - Aumentar hidratación (≥ 2 L/día).
 - Suspender diuréticos tiazídicos si es posible.
-

5.4. Pseudogota (manejo específico)

- No existe tratamiento hipouricemiante.
 - Ataques tratados con **AINEs**, **colchicina** o **corticoides** (similares a gota).
 - Identificar y tratar causas predisponentes (hipomagnesemia, hiperparatiroidismo).
-

6. Complicaciones

En gota:

- Artritis crónica destructiva.
- Tofos subcutáneos.
- Nefropatía úrica: depósitos de urato en túbulos renales.
- Litiasis renal por ácido úrico.

En pseudogota:

- Daño articular crónico con condrocalcinosis extensa.
 - Artritis crónica secundaria a depósito de cristales.
-

7. Pronóstico

El pronóstico de la gota es **excelente con tratamiento adecuado**.

La terapia hipouricemiante reduce crisis y disuelve tofos progresivamente.

Sin tratamiento, puede progresar a gota tofácea crónica y daño articular irreversible.

Factores de mal pronóstico:

- Inicio precoz (<30 años).
 - Hiperuricemia severa (>9 mg/dL).
 - Insuficiencia renal crónica.
 - Adherencia deficiente al tratamiento o dieta.
-

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. La **monoartritis del hallux** en un varón hipertenso tratado con diuréticos es casi patognomónica de **gota aguda**.
2. La **confirmación diagnóstica** es mediante **cristales de urato birrefringentes negativos** en líquido sinovial.
3. El tratamiento de elección del **ataque agudo** son **AINes o colchicina**.
4. **No iniciar ni suspender alopurinol durante una crisis**.
5. El objetivo terapéutico es **ácido úrico <6 mg/dL**.
6. En pseudogota, los cristales son **romboidales y birrefringentes positivos**.

7. En EUNACOM, las preguntas típicas evalúan el manejo de la crisis aguda y el reconocimiento de la clínica clásica (podagra).

Errores comunes:

- Diagnosticar gota solo por hiperuricemia sin clínica.
 - Usar alopurinol en pleno ataque agudo.
 - No ajustar dosis en insuficiencia renal.
 - Omitir profilaxis con colchicina al iniciar hipouricemiantes.
 - Mantener diuréticos tiazídicos pese a hiperuricemia.
-

9. Resumen final (6 ideas clave)

1. La **gota** es causada por depósito de **cristales de urato monosódico** por hiperuricemia crónica.
2. El cuadro típico es **monoartritis aguda del hallux (podagra)**.
3. El **diagnóstico se confirma con cristales birrefringentes negativos** en líquido sinovial.
4. El tratamiento agudo son **AINEs o colchicina**; el mantenimiento, **alopurinol**.
5. La **pseudogota** se debe a **cristales de pirofosfato de calcio**, afecta rodillas y muñecas.
6. En **EUNACOM**, los puntos clave son:
 - No usar alopurinol en crisis aguda.
 - Reconocer cristales birrefringentes.
 - Indicar colchicina o AINE en manejo inicial.